

SEGUNDO-PARCIAL-BIOQUIMICA-CLINI...



Anónimo



Bioquímica Clínica



3º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

SEGUNDO PARCIAL BIOQUÍMICA CLÍNICA

1. En la fenilcetonuria es cierto que:

- a) Es una alteración del catabolismo de la fenilalanina
- b) Se produce por acumulación de xantina
- c) Es una alteración del transporte de la prolina
- d) Está causada por la pérdida de triptófano
- e) Se produce por déficit enzimático de la cistatinina sintasa

2. En un proteinograma (electroforesis de proteínas plasmáticas), la presencia de una banda discreta en la fracción γ puede ser indicativo de:

- a) una hipoalbuminemia
- b) una hiperalbuminemia
- c) Ninguna de las opciones es correcta
- d) paraproteína o componente monoclonal
- e) paraproteína o componente policlonal

3. De las siguientes afirmaciones, señale la opción incorrecta:

- a) Las HDL son lipoproteínas que no presentan riesgo aterogénico.
- b) El déficit de tiamina impide la síntesis de ácidos grasos.
- c) La linfangiectasia puede cursar con diarrea y esteatorrea
- d) Para valorar el metabolismo de las lipoproteínas se analiza el aspecto del suero tras dejarlo reposar a 4°C toda la noche
- e) La enfermedad de Zellweger se produce por una alteración en el metabolismo de los fosfolípidos

4. ¿Qué magnitud bioquímica analizarías para valorar la integridad de las células del hígado?

- a) albúmina
- b) gammaglutamiltransferasa
- c) fosfatasa alcalina
- d) bilirrubina
- e) alanina aminotransferasa

WUOLAH

5. Para el estudio de la hemostasia primaria se analiza:

- a) el tiempo de hemorragia o sangría
- b) el tiempo de quick
- c) el tiempo de tromboplastina parcial activa
- d) el tiempo de protombina
- e) el tiempo de trombina

6. El déficit de AcetilCoA carboxilasa afecta a:

- a) la síntesis de los ácidos grasos
- b) la degradación de los ácidos grasos
- c) la síntesis y degradación de ácidos grasos y cuerpos cetónicos
- d) la síntesis de los cuerpos cetónicos
- e) la degradación de los cuerpos cetónicos

7. El albinismo:

- a) Se produce por déficit enzimático de tirosinasa que impide la formación de melanina
- b) Se produce por déficit enzimático de tirosinasa que permite la formación de melanina
- c) Se produce por déficit enzimático de tirosinasa que impide la formación de melanina
- d) Se produce por déficit enzimático de tirosinasa que permite la formación de melanina
- e) todas las opciones son falsas porque se produce por fallos en el transporte de melanina

8. En una alteración hepática isquémica, es cierto que:

- a) la relación entre ALT/LDH es inferior a 1
- b) la relación entre ALT/AST es superior a 1
- c) la relación entre AST/ALT es inferior a 1
- d) la relación entre AST/ALT es superior a 1
- e) la relación entre ALT/AST es inferior a 1

9. El anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células sanguíneas:

- a) Es la función de la médula ósea
- b) es la función de la hemostasia
- c) es la función de la coagulación
- d) es la función de las células madre troncohematopoyéticas
- e) es la función del microambiente hematopoyético

10. Con respecto a las plaquetas es cierto que:

- a) son leucocitos mononucleares
- b) son las células menos abundantes en sangre
- c) son monocitos Polimorfonucleares
- d) su recuento es importante para el diagnóstico de trastornos hemorrágicos
- e) proceden de la fragmentación de los eritrocitos

11. La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en el metabolismo de aminoácidos:

- a) ácidos
- b) alifáticos ramificados
- c) básicos
- d) alifáticos no ramificados
- e) azufrados

12. La presencia de cristales hexagonales planos en la orina de un paciente:

- a) puede ser indicativo de que padece síndrome del pañal azul
- a) puede ser indicativo de que padece gota
- a) puede ser indicativo de que padece cistinuria
- a) puede ser indicativo de que padece xantinuria hereditaria
- a) puede ser indicativo de que padece aciduria orótica

13. Pueden producirse alteraciones en el metabolismo de los triglicéridos como consecuencia de:

- a) deficiencia de lipasa lisosomal y HMG-CoA liasa
- b) deficiencia de saposinas y lipasa lisosomal
- c) deficiencia de glicerol quinasa y de saposinas
- d) deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa y HMG-CoA liasa
- e) deficiencia de glicerol quinasa y de lipasa lisosomal

14. Dentro de lo que se engloba como proteínas de fase aguda se incluyen:

- a) La prealbúmina
- b) La Ceruloplasmina
- c) La albúmina
- d) Todas las proteínas de la fracción γ
- e) Todas las proteínas de la fracción β

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



15. De las siguientes afirmaciones señala la opción correcta:

- a) Las alteraciones de la betaoxidación producen hiperglucemia no cetónica
- b) todas las opciones son correctas
- c) los xantomas y xantelasmas son características patognomónicas de las hipertrigliceridemias.
- d) algunas esfingolipidosis son mucopolisacaridosis
- e) enfermedades hepáticas, pancreáticas o intestinales pueden alterar el metabolismo lipídico.

16. La enfermedad de Refsum es:

- a) una alteración en el metabolismo de los fosfolípidos
- a) una alteración en el metabolismo de los esfingolípidos
- a) una alteración en el metabolismo de los mucopolisacáridos
- a) una alteración en el metabolismo de los polisacáridos
- a) una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos

17. La homocistinuria se produce por alteración en el metabolismo de aminoácidos:

- a) aromáticos
- b) alifáticos ramificados
- c) básicos
- d) alifáticos no ramificados
- e) azufrados

18. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:

- a) ninguna de las opciones es correcta
- b) la separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- c) la reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales
- d) la reacción de Biuret se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- e) los métodos inmunoquímicos permiten analizar proteínas totales.

19. De las siguientes afirmaciones señala la opción incorrecta:

- a) todas las opciones son falsas
- b) una proteinuria específica o selectiva sería indicativo de alteración de la función tubular
- c) la prueba de restricción hídrica permite valorar la función tubular del riñón
- d) la prueba de carga ácida se utiliza para valorar la capacidad del riñón de mantener el equilibrio ácido-básico
- e) una proteinuria inespecífico o no selectiva, sería indicativo de alteración de la función glomerular.

20. La hemoglobina corpuscular media (HCM) es:

- a) el contenido medio en pg de hemoglobina en cada eritrocito
- b) el valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dl de hematíes
- c) ninguna opción es correcta
- d) es el valor medio del volumen de los hematíes, expresado en femtolitros
- e) representa la proporción de eritrocitos en el volumen total de sangre expresado en porcentaje

21. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:

- a) todas las opciones son correctas
- b) se analiza el aspecto del suero tras dejarlo reposar a 4° C toda la noche
- c) la concentración de Apo A en plasma puede utilizarse como alternativa a la concentración de HDL-Colesterol
- d) el lipidograma puede revelar la existencia de hipo o hiperlipoproteinemias
- e) las HDL-Colesterol se pueden determinar por ultracentrifugación y precipitación selectiva al adicionar sal de ácido fosfotúngstico.

22. El aclaramiento de creatinina calculado en un volumen de 2400 ml de orina recogido durante 20 horas, a una concentración en orina de 8 mmol/L y plasmática de 200μmol/L fue de:

- a) 80 ml/min
- b) ninguna de las opciones es correcta
- c) 96 ml/min
- d) 80 μl/min
- e) 96 μl/min

23. Con respecto a las plaquetas es cierto que:

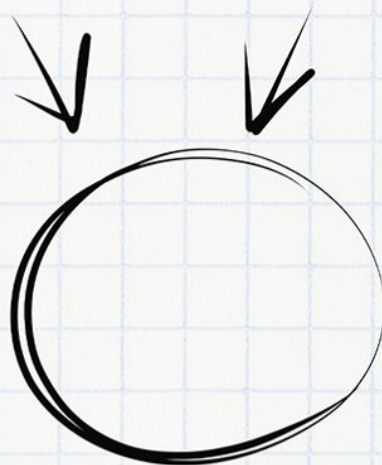
- a) son monocitos polimorfonucleares
- b) son leucocitos mononucleares
- c) su recuento es importante para el diagnóstico de trastornos hemorrágicos
- d) son las células menos abundantes en sangre
- e) proceden de la fragmentación de los eritrocitos

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

24. Con respecto al estudio bioquímico de la función renal:

- a) se suele analizar el aclaramiento de creatinina para estudiar alteraciones glomerulares
- b) se suele analizar el aclaramiento de creatinina para estudiar alteraciones tubulares
- c) se puede analizar la hemoglobina par estudiar las alteraciones tanto tubulares como glomerulares
- d) se suele analizar la integridad del epitelio y la osmolalidad plasmática para estudiar alteraciones glomerulares
- e) se suele analizar la integridad del epitelio y el mantenimiento del equilibrio ácido básico para estudiar alteraciones glomerulares

25. De las siguientes afirmaciones señala la opción correcta:

- a) la iminoglicinuria se produce por alteración en el transporte de los aminoácidos
- b) la homocistinuria se produce por alteración en el transporte de lo aminoácidos
- c) la aciduria orótica hereditaria se produce por alteración en el metabolismo de las purinas
- d) la xantinuria hereditaria cursa con hipouricemia
- e) el síndrome de Lesh-Nyhan se produce por alteración en el metabolismo de las pirimidinas

26. De las siguientes afirmaciones señala la opción correcta:

- a) bajas concentraciones de albúmina en sangre pueden ser indicativos de insuficiencia hepática crónica
- b) bajas concentraciones de hemoglobina en sangre puede ser indicativo de insuficiencia renal aguda
- c) la albúmina, transaminasas y creatinina, son magnitudes que informan de lesión hepática y su extensión
- d) elevadas concentraciones de hemoglobina en sangre, pueden ser indicativo de insuficiencia renal crónica
- e) la albúmina, transaminasas y creatinina, son magnitudes que informan de lesión renal y su extensión

27. De las siguientes afirmaciones relacionadas con las alteraciones del ciclo de la urea, señala la opción incorrecta:

- a) la gravedad depende de la enzima afectada y el grado de la deficiencia
- b) puede manifestarse por la elevación del amonio plasmático
- c) elevadas concentraciones de urea en sangre son indicativas de dicha alteración
- d) puede producirse por déficit de la Carbamoil-fosfato-sintetasa I
- e) puede producirse por déficit de orinitina-transcarbomoilasa

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

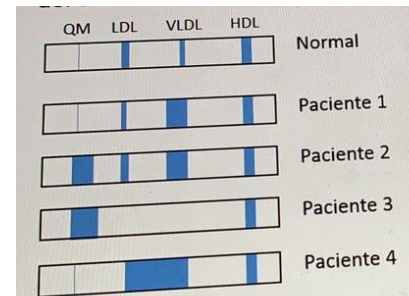
WUOLAH

28. CASO CLÍNICO: según la historia y los resultados recogidos en el siguiente caso clínico, el posible diagnóstico es:

Un adolescente de 16 años acude al médico con dolores abdominales constantes, episodios diarreicos frecuentes y cierto grado de desnutrición. Se le realiza un análisis de sangre, para lo cual se le recomienda un ayuno de 12-14h y se obtienen los siguientes resultados:

Después de obtener una muestra de suero que se dejó reposar en frío, se observó que su aspecto al día siguiente era turbio. También se realizó un lipidograma obteniéndose el siguiente resultado, siendo el paciente 1 el lipidograma del adolescente. Seleccione 1:

		I.R
[Na ⁺]	110 (mmol/L)	135-145 (mmol/L)
[K ⁺]	3,2 (mmol/L)	3,4-4,9 (mmol/L)
[Ca ⁺⁺]	94 (mmol/L)	95-105 (mmol/L)
[Cl ⁻]	97 (mmol/L)	98-106 (mmol/L)
[HCO ₃ ⁻]	20 (mmol/L)	22-28 (mmol/L)
[NH ₄ ⁺]	33 (μmol/L)	15-35 (μmol/L)
[Glucosa]	5,5 (mmol/L)	3-6 (mmol/L)
[Colesterol]	175 (mg/dl)	< 240 (mg/dl)
[triglicéridos]	564 (mg/dl)	< 200 (mg/dl)
[Urea]	3,1 (mmol/L)	2,5-8 (mmol/L)
[Creatinina]	50 (μmol/L)	40-130 (μmol/L)
[Hemoglobina]	11 (g/dl)	12-16 (g/dl)
[Alanina-aminotransferasa] (ALT)	0,6 (μKat/L)	0,05-0,92 (μKat/L)
[Aspartato-aminotransferasa] (AST)	0,5 (μKat/L)	0,2-0,8 (μKat/L)
[Fosfatasa alcalina] (FA)	2,8 (μKat/L)	1,3-4,7 (μKat/L)
[γ-glutamyl-transferasa] (GGT)	0,03 (μKat/L)	< 0,6 (μKat/L)



- a) Hiperlipoproteínemia tipo V
- b) hiperlipoproteínemia tipo I o hiperquilomicronemia familiar
- c) hiperlipoproteínemia tipo IV o hiperbetaproteínemia familiar
- d) hiperlipoproteínemia tipo IIb o hiperbetaproteínemia familiar
- e) hiperlipoproteínemia tipo IV o hipertriacilgliceridemia familiar

29. Si en una analítica sanguínea nos encontramos con los resultados de la tabla, podríamos decir que el paciente:

- a) Está sano
- b) puede sufrir una alteración hepática
- c) puede sufrir una alteración cardíaca
- d) puede sufrir una alteración ósea
- e) puede sufrir una alteración renal

WUOLAH